

衛教專欄 • 胰臟癌新藥

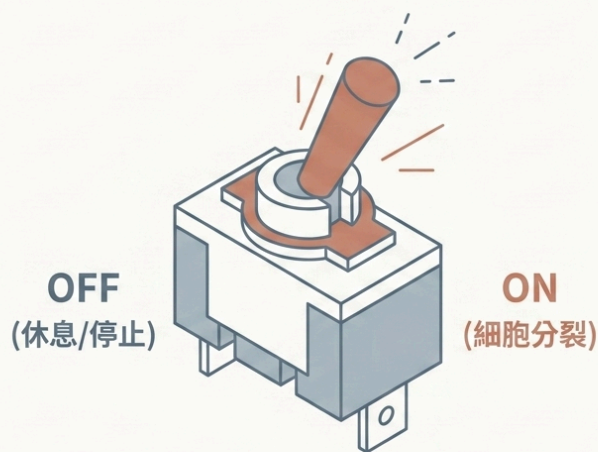
胰臟癌新藥 Daraxonrasib 是什麼？ 存活期接近翻倍，破解 RAS 「無法投藥」難題

撰文・章明珠醫師 • 閱讀時間 約 6 分鐘 • 更新 2026 年 7 月

摘要

九成以上的胰臟癌都帶有 RAS 基因突變，但它長年被醫學界稱為「無法投藥 (Undruggable)」的目標——明明知道敵人在哪裡，卻始終沒有武器。新藥 Daraxonrasib 用全新的「分子膠」技術破解了這道難題：它能鎖定活化中的 RAS、涵蓋多種突變型別。第三期臨床試驗中，晚期胰臟癌患者的中位存活期由 6.7 個月延長到 13.2 個月、接近翻倍，死亡風險降低約 60%。這不是胰臟癌的「神藥」，卻是精準醫療反攻的重要起點。

RAS 突變：卡死在「ON」的失控引擎



正常的 RAS 基因是細胞的煞車與油門。但在腫瘤細胞中，它發生了突變 (如 G12D、G12V)。

突變的 RAS 永遠卡在「活化狀態」。結果就是：無限分裂、生長、轉移。

圖 RAS 突變——像一顆卡死在「ON」的引擎開關：正常時該開就開、該關就關，突變後卻永遠停在活化狀態，不斷下達生長、分裂與轉移的指令。

01 診間裡的沉默：無法投藥的癌王

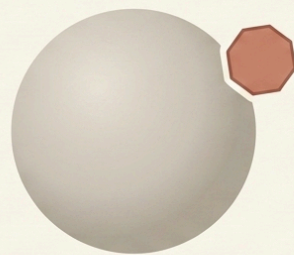
在診間裡，我經常遇到病人拿著胰臟癌基因檢測報告，充滿期待地問我：「醫師，我的胰臟癌有基因突變，是不是有標靶藥？」幾年前，這個問題總讓我沉默。因為九成以上的胰臟癌都帶有 RAS 基因突變，但它卻被醫學界稱為「無法投藥 (Undruggable)」的目標。明明知道敵人在哪裡，卻始終沒有武器可以攻擊，是胰臟癌治療最大的困境。

為什麼 RAS 這麼難對付？可以把一般標靶藥想像成一把鑰匙，需要找到蛋白上的凹槽才能卡住它。偏偏 RAS 蛋白就像一顆塗滿油的保齡球，表面非常光滑，藥物幾乎沒有地方可以抓住。全球藥廠投入數十年研究，始終無法突破這道障礙。

被稱為「無法投藥 (Undruggable)」的完美球體



一般基因：表面有口袋與凹槽，藥物容易卡住。



RAS 蛋白：表面異常平滑，沒有任何可以讓小分子藥物結合的「口袋」。

“就像試圖用手抓住一顆塗滿油的保齡球。”

圖 被稱為「無法投藥」的完美球體——一般蛋白表面有凹槽可讓藥物卡住；RAS 蛋白表面卻異常平滑，就像試圖用手抓住一顆塗滿油的保齡球。

從臨床角度，我更喜歡把 RAS 想成細胞裡的引擎開關。正常情況下，它會在需要時開啟（ON）、完成任務後關閉（OFF）。但胰臟癌中的 RAS 突變，就像油門卡死，一直停留在 ON 狀態，不斷發出癌細胞生長、分裂與轉移的指令。過去的第一代 RAS 標靶藥只能攻擊少數特殊突變、而且只能作用在 OFF 狀態，因此對大部分胰臟癌患者幫助有限。

02 Daraxonrasib 的突破：分子膠技術

Daraxonrasib 採用了全新的「分子膠（Molecular Glue）」技術。它不像過去一直尋找蛋白表面的凹槽，而是像一張超級雙面膠——一端黏住 RAS，另一端結合細胞內的 CypA 蛋白，把原本抓不住的 RAS 固定起來。更重要的是，它能直接鎖定活化中的 ON 狀態 RAS，而且可涵蓋多種不同的 RAS 突變，不再只侷限於少數型別。這是 RAS 標靶治療的重要里程碑。

03 臨床試驗看到什麼？

根據最新第三期臨床試驗（RASolute 302），在第一線化療失敗的晚期胰臟癌患者中：中位存活期由 6.7 個月延長至 13.2 個月、接近翻倍；死亡風險降低約 60%。它是每日口服藥物，副作用以皮疹及腸胃不適為主，整體耐受性較傳統化療佳。對胰臟癌而言，存活期能接近翻倍，是近年最重要的突破之一。

真槍實彈的成績單：Phase 3 全球臨床試驗

針對已對第一線化療產生抗藥性的晚期胰臟癌患者 (RASolute 302)

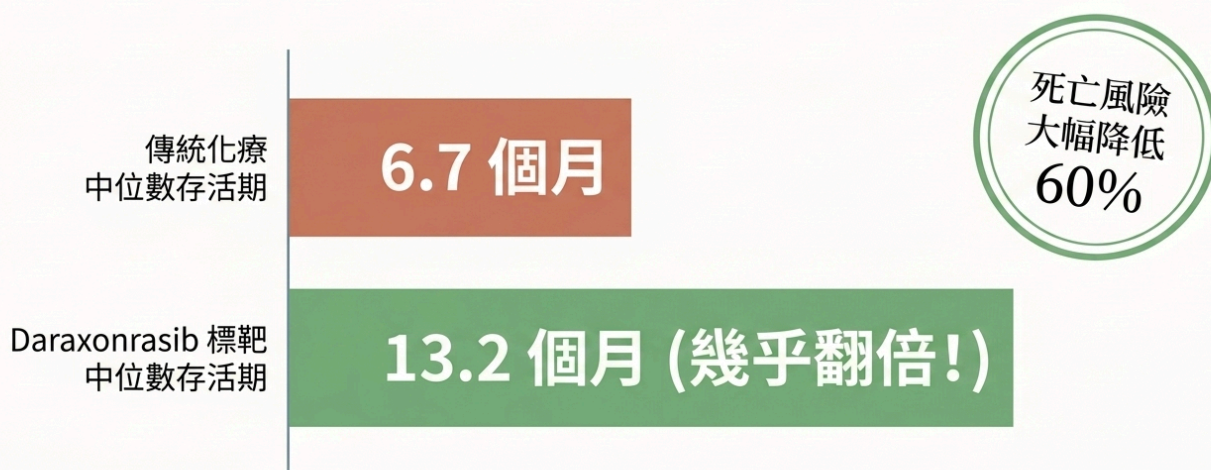


圖 真槍實彈的成績單 (Phase 3, RASolute 302) ——傳統化療中位存活 6.7 個月，Daraxonrasib 延長至 13.2 個月幾乎翻倍，死亡風險大幅降低約 60%。

04 希望出現，但挑戰仍在

研究也發現，Daraxonrasib 不只是抑制癌細胞，還可能改善腫瘤微環境，讓免疫細胞更容易辨識並攻擊癌細胞，因此未來有機會與免疫治療搭配，發揮更大的效果。不過，癌細胞仍可能產生新的抗藥性——例如再次發生基因突變、啟動其他訊號路徑，或改變藥物作用機制。因此，如何利用合併治療延長療效，仍是目前全球研究的重要方向。

05 章醫師的提醒

Daraxonrasib 並不是胰臟癌的「神藥」，但它象徵著一件更重要的事——過去被認為「無法投藥」的 RAS，終於被成功攻克。這也提醒我們，精準醫療的第一步不是急著找藥，而是要先了解腫瘤的基因特性，才能判斷是否有機會接受最新的標靶治療或臨床試驗。胰臟癌的治療仍然充滿挑戰，但醫學正在一步一步前進。每一次突破，都代表病人多了一個選擇，也多了一份希望。這不是終點，而是精準醫療反攻的開始。

重點 重點整理

五個重點，一次帶走

- 1 九成以上胰臟癌帶有 **RAS 突變**，長年被視為「無法投藥」的目標。
- 2 RAS 像塗油的保齡球、又像卡死在 **ON** 的引擎，傳統標靶藥難以作用。
- 3 Daraxonrasib 用「**分子膠**」技術，鎖定活化(ON)狀態、涵蓋多種突變型別。
- 4 第三期試驗：中位存活期 **6.7 → 13.2 個月**、死亡風險降約 60%，每日口服。
- 5 精準醫療第一步是**基因檢測**；仍有抗藥性挑戰，合併治療是未來方向。

本網站內容僅供一般醫療知識與健康教育參考，不能取代醫師的診斷、治療或個別醫療建議。每位讀者的健康狀況不同，如有症狀、檢查異常或治療需求，請諮詢合格醫療專業人員。本文內容為章明珠醫師原創，歡迎分享本文原始連結；未經書面授權，請勿全文轉載、擷取圖表、改作、剪輯或重新發布。

FAQ 常見問題

Q1 Daraxonrasib 是什麼？

它是一款針對 RAS 的口服標靶新藥，採用「分子膠」技術，把原本表面光滑、抓不住的 RAS 固定住，並能直接鎖定活化中的 ON 狀態、涵蓋多種 RAS 突變型別，是 RAS 標靶治療的重要里程碑。

Q2 哪些患者可能適合？

第三期試驗收的是帶 RAS（如 KRAS）突變、且第一線化療失敗的晚期胰臟癌患者。是否適合，需先經基因檢測確認突變型別，並由專科醫師評估整體病況與治療條件。

Q3 有哪些副作用？

副作用以皮疹及腸胃不適為主，整體耐受性較傳統化療佳。實際反應因人而異，用藥期間仍需由醫師監測與調整。

Q4 為什麼要做基因檢測？

精準醫療的第一步不是急著找藥，而是先了解腫瘤的基因特性。唯有先確認是否帶有 RAS 等突變，才能判斷是否有機會接受最新的標靶治療或臨床試驗。

Q5 台灣何時可能使用？

Daraxonrasib 仍屬近年第三期試驗階段的新藥，實際的上市與健保給付時程需視主管機關核准而定，本文未載明確切時間。建議與您的胰臟專科醫師討論，或留意相關臨床試驗的收案資訊。

持續收到有溫度的胰臟衛教

訂閱電子報，並追蹤章醫師，第一時間收到新的胰臟健康專欄與衛教影片。

訂閱電子報

追蹤章醫師

上一篇

模仿之王：CA19-9 破 1000、最像胰臟
癌的自體免疫胰臟炎

延伸閱讀

KRAS 是什麼？胰臟癌基因檢測與標靶治
療

章醫師・胰臟健康誌

PANCREAS • HEALTH JOURNAL | 衛教資訊僅供參考，不能取代專業醫療診斷 | © 章明珠醫師 原創